SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	5569739
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	02/01/2026
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	13/01/2026

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA			
CIP EUROPEO CIP EUROPEU			
SEXO SEXE	SEX2	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Motivo de ingreso / Motiu d'ingrés

Mujer de 87 años de edad que ingresa por ENFERMEDAD COMUN procedente de Hospital General de Castelló - NEUMOLOGIA (URGENCIAS)

Antecedentes / Antecedents

Niega alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes Respiratorios: -Ex-fumadora desde hace mas de 40 años de 4 cig/dia. -Tras viaje prolongado en coche a Alemania, TVP + TEP bilateral en Francia en 2016 y en 2022. En tratamiento actualmente con Rivaroxaban. - TEP 2022 (con ingreso en Neumología). - TBC en la infancia (TAC del 2017 hallazgos compatibles con cambios post TBC). - Familiar refiere diagnóstico de EPOC, pero no lleva tto BD. No consta en historial PFR. - Portadora de VMNI por SAOS (BiPAP puesta en Navarra) --> Lleva más de 1 año sin ponerse la máquina - Portadora de OCD 2 lpm las 24 horas - En seguimientgo en CCEE de Neumología (NEM-VASC) con angioTC en Julio 2025 con hallazgo de TEP. Probable TEP crónico. Pendinete de ETT. * Última ETT 2023: Ventrículo izquierdo de tamaño normal con paredes no engrosadas y con buena función sistólica global (FEVI 73%) sin alteraciones de la contractilidad segmentaria. Ventrículo derecho de tamaño normal con buena función sistólica (TAPSE: 17mm S' por TDI 15,3cm/s). Válvula aórtica trivalva de estructura normal con flujos normales. . Válvula mitral de estructura normal con flujo normal. Llenado tipo alteración de la relajación. Insuficiencia tricuspídea ligera que permite estimar una PsAP de 35 mmHG. Tiempo de aceleración de VP corto 95ms. Vena cava inferior no dilatada y con buen colapso inspiratorio. Ausencia de derrame pericárdico. Antecedentes personales: - Dislipemia. - Ictus vertebrobasilar en septiembre 2021. - Deterioro cognitivo desde ingreso por ictus vertebrobasilar en estudio por Neurología. - Elevación hemidiafragma derecho. - Insuficiencia tricuspídea moderada. Tratamiento habitual: Hidroferol (Vit D) 0,266mg, sol oral de 1,5ml 1 sol oral/30 días Rivaroxaban 20mg 1 comp/24h Haloperidol en sol gotas de 10 gotas orales/24h Voltadol 11,/g gel , 60 g 1 envase/7 días Social: Vive con su marido. Camina con bastón, neccesita ayuda para vestirse y asearse.

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual

Mujer de 87 años es remitida de Centro de día por disnea.
Dificultad para realización de anamnesis por sdr confusional y deterioro cognitivo.
Intentamos realizar anamnesis de manera telefonica con familiar (marido, habla francés y poco español).

Refiere acudir a Urgencias por cuadro de aumento de su disnea basal hasta hacerse de reposo asociado a tos sin expectoración. Autoesuchca de sibilantes. No dolor torácico. No fiebre ni sensación distérmica.
Edematización crónica de MMII sin cambios en el ritmo de diuresis.
No ortopnea.
No clínica GI ni urinaria.

Exploración física / Exploració física

02-01-2026 11:43 - TA: 172/81 mmHg; Tª: 36.4 ºC ºC (Timpánica); FC: 91 lat/min; Sat. O2: 86 % (Con Oxígeno); Vol. O2: 8 L/m;
MAG, somnolienta. taquipneica en reposo.
Auscultación cardíaca: Tonos ritmicos, sin soplos.
Auscultación Pulmonar: murmullo vesicular disminuído de forma global, roncus diseminados y sibilantes aislados con espiración alargada. Incremento del trabajo respiratorio con utilización de musculatura accesoria.
MMII: edemas crónicos en MMII.

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	5569739
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	02/01/2026
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	13/01/2026

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA			
CIP EUROPEO CIP EUROPEU			
SEXO SEXE	SEX2	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries

ECG: RS a 84 lpm, eje +60º, PR 0.16 seg, QRS estrecho sin alteraciones de la repolarización. GSA (FiO2:40%): PH: 7.29; pCO2: 65 mmHg; pO2: 76 mmHg; HCO3: 26.8 mmol/L; EBA: +4.7 mmol/L; Láctico: 1.8 mmol/L. GSA 16.00H: pH: 7.43 pO2: 62 mmHg satO2: 94.7% CO2: 46 mmHg HCO3: 30.5 mmol/L AG: 6 mmol/L Hb: 14.7 g/dL Glu: 182 mg/dL Lactato: 1.1 mmol/L K: 5.3 mmol/L Na: 133 mmol/L Ca: 5.46 mg/dL Hemograma HEMATIES 4,85 x 10^6/µL (4,20 - 6,10) HEMOGLOBINA 14,6 g/dL (12,0 - 18,0) HEMATOCRITO 44,9 % (37,0 - 52,0) VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 92,5 fL (80 - 94) HBG CORPUSCULAR MEDIA 30,1 pg (27,0 - 31,0) CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA * 32,5 g/dL (33,0 - 37,0) RDW-CV 13,3 % (11,6 - 14,5) LEUCOCITOS * 12,80 x 10^3/µL (4,80 - 10,80) NEUTROFILOS * 10,70 x 10^3/µL (1,90 - 8,00) LINFOCITOS * 0,80 x 10^3/µL (0,90 - 5,20) MONOCITOS * 1,20 x 10^3/µL (0,16 - 1,00) EOSINOFILOS 0,00 x 10^3/µL (0,00 - 0,80) BASOFILOS 0,00 x 10^3/µL (0,00 - 0,20) NEUTROFILOS % * 83,8 % (40,0 - 70,0) LINFOCITOS % * 6,3 % (19,0 - 48,0) MONOCITOS % * 9,4 % (3,4 - 9,0) EOSINOFILOS % 0,2 % (0,0 - 7,0) BASOFILOS % 0,3 % (0,0 - 1,5) PLAQUETAS 239 x 10^3/µL (130 - 400) Hemostasia T. PROTROMBINA * 18,9 seg (9,0 - 13,0) INDICE DE QUICK * 47,0 % (70,0 - 120,0) INR * 1,66 (0,80 - 1,20) TP RATIO * 1,64 (0,80 - 1,20) TTPA RATIO 1,16 (0,80 - 1,25) T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 36,4 seg (25,1 - 38) FIBRINOGENO * 565,00 mg/dL (200,00 - 400,00) T.TROMBINA 19,40 seg (18.4 - 27.5) Tiempo de trombina Ratio 0,69 Bioquímica GLUCOSA * 219 mg/dL (70 - 110) UREA 31 mg/dL (10.0 -- 50.0) CREATININA 0,71 mg/dL (0,51 - 0,95) FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 76,71 ml/min/sup (60.00-200.0) SODIO 136 mmol/L (134-145) POTASIO 4,95 mmol/L (3.50-5.00) CLORO 100 mmol/L (95-105) BILIRRUBINA TOTAL * 0,36 mg/dL (0.50-1.0) GPT 18 UI/L (10-37) GOT 26 UI/L (10-38) GGT * 85 UI/L (7.0-50) FOSFATASA ALCALINA 115 UI/L (40-145) CPK 56 UI/L (50-195.0) LDH 218 UI/L (0 - 248) PROTEINA C REACTIVA * 45,20 mg/L (1.00-10.0) FERRITINA 125 ng/mL (20 - 300) NT- PROBNP * 220 pg/mL (20 - 125) PROCALCITONINA 0,03 ng/mL (0.00-0.10) TROPONINA ULTRASENSIBLE 9,74 ng/L (14,00) MIOGLOBINA 48 ng/mL (25 - 58) Virus respiratorios PCR Virus Influenza A NEGATIVO PCR Virus Influenza A/B NEGATIVO PCR Virus Influenza B NEGATIVO PCR Nuevo Coronavirus 2019-nCoV NEGATIVO Rx Tórax: No condensaciones pulmonares. Mínimo pinzamiento de seno costofrénico izquierdo. AL ALTA: Gasometría arterial FiO2 32 % Temperatura 36,2 ºC Ph sanguíneo 7,440 (7,350 - 7,450) Ph corregido 7,450 (7,350 - 7,450) PCO2 sanguíneo * 46,0 mmHg (35,0 - 45,0) PCO2 sanguíneo corregido 44,0 mmHg (35,0 - 45,0) PO2 sanguíneo * 69,0 mmHg (90,0 - 100,0) PO2 sanguíneo corregido * 65,0 mmHg (90,0 - 100,0) Saturación oxígeno 95,7 % (90,0 - 100,0) Oxihemoglobina * 93,80 % (96,00 - 100,00) Carboxihemoglobina 1,30 % (0,00 - 2,00) Metahemoglobina 0,60 % (0,00 - 1,50) Hemoglobina reducida 4,20 % (0,00 - 5,00) Bicarbonato standard 29,4 mmol/L Bicarbonato calculado * 31,2 mmol/L (22,0 - 28,0) Exceso de base en sangre * 5,9 mmol/L (-2,0 - 3,0) BIOQUIMICA GLUCOSA * 140 mg/dL (70 - 110) UREA * 76 mg/dL (10.0 -- 50.0) CREATININA 0,70 mg/dL (0,51 - 0,95) FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 77,76 ml/min/sup (60.00-200.0) SODIO 141 mmol/L (134-145) POTASIO 4,15 mmol/L (3.50-5.00) CLORO 99 mmol/L (95-105) GPT * 250 UI/L (10-37) PROTEINA C REACTIVA 1,42 mg/L (1.00-10.0) NT- PROBNP * 177 pg/mL (20 - 125) HEMOGRAMA HEMATIES 5,06 x 10^6/µL (4,20 - 6,10) HEMOGLOBINA 15,5 g/dL (12,0 - 18,0) HEMATOCRITO 45,2 % (37,0 - 52,0) VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 89,5 fL (80 - 94) HBG CORPUSCULAR MEDIA 30,6 pg (27,0 - 31,0) CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA 34,2 g/dL (33,0 - 37,0) RDW-CV 13,0 % (11,6 - 14,5) LEUCOCITOS * 14,30 x 10^3/µL (4,80 - 10,80) NEUTROFILOS * 11,60 x 10^3/µL (1,90 - 8,00) LINFOCITOS 1,40 x 10^3/µL (0,90 - 5,20) MONOCITOS * 1,30 x 10^3/µL (0,16 - 1,00) EOSINOFILOS 0,00 x 10^3/µL (0,00 - 0,80) BASOFILOS 0,00 x 10^3/µL (0,00 - 0,20) NEUTROFILOS % * 80,9 % (40,0 - 70,0) LINFOCITOS % * 9,8 % (19,0 - 48,0) MONOCITOS % * 9,1 % (3,4 - 9,0) EOSINOFILOS % 0,1 % (0,0 - 7,0) BASOFILOS % 0,1 % (0,0 - 1,5) PLAQUETAS 245 x 10^3/µL (130 - 400)

SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
UNIDAD UNITAT	
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	5569739
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	02/01/2026
FECHA DE ALTA DATA D'ALTA	13/01/2026

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT

PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA			
CIP EUROPEO CIP EUROPEU			
SEXO SEXE	SEX2	FECHA DE NACIMIENTO DATA DE NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Informe de Alta de Hospitalización / Informe d'Alta d'Hospitalització

Evolución / Evolució

Al ingreso se pauta VNI, oxigenoterapia con OAF y tratamiento médico. Presenta tórpida evolución inicial, con posterior mejoría, que permite retirar OAF y VNI. Dadas las caraterísticas de la paciente, demencia avanzada, y previsión de larga convalecencia, se solicita traslado a HACLE.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal

BRONQUITIS AGUDA

Diagnósticos secundarios / Diagnòstics secundaris

INSUFIENCIA RESPIRATORIA GLOBAL CON ACIDOSIS RESPIRATORIA RESUELTA AOS BRONCOESPASMO
DEMENCIA SOSPECHA AIT

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta

- Oxígeno en gafas nasales a 0.5 lpm las 24h.
- Prednisona 30mg 1/2 comprimido al día durante 3 días más y suspender.
- Resto de su tratamiento según venía tomando previamente.

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta

MEDICO CABECERA

Responsable:

ADJUNTO

Firma digital / Signatura digital:

Sección / Secció: NEUMOLOGIA

Fecha / Data: 17/07/2026 19:06:14

Fecha creación / Data creació: 13/01/2026